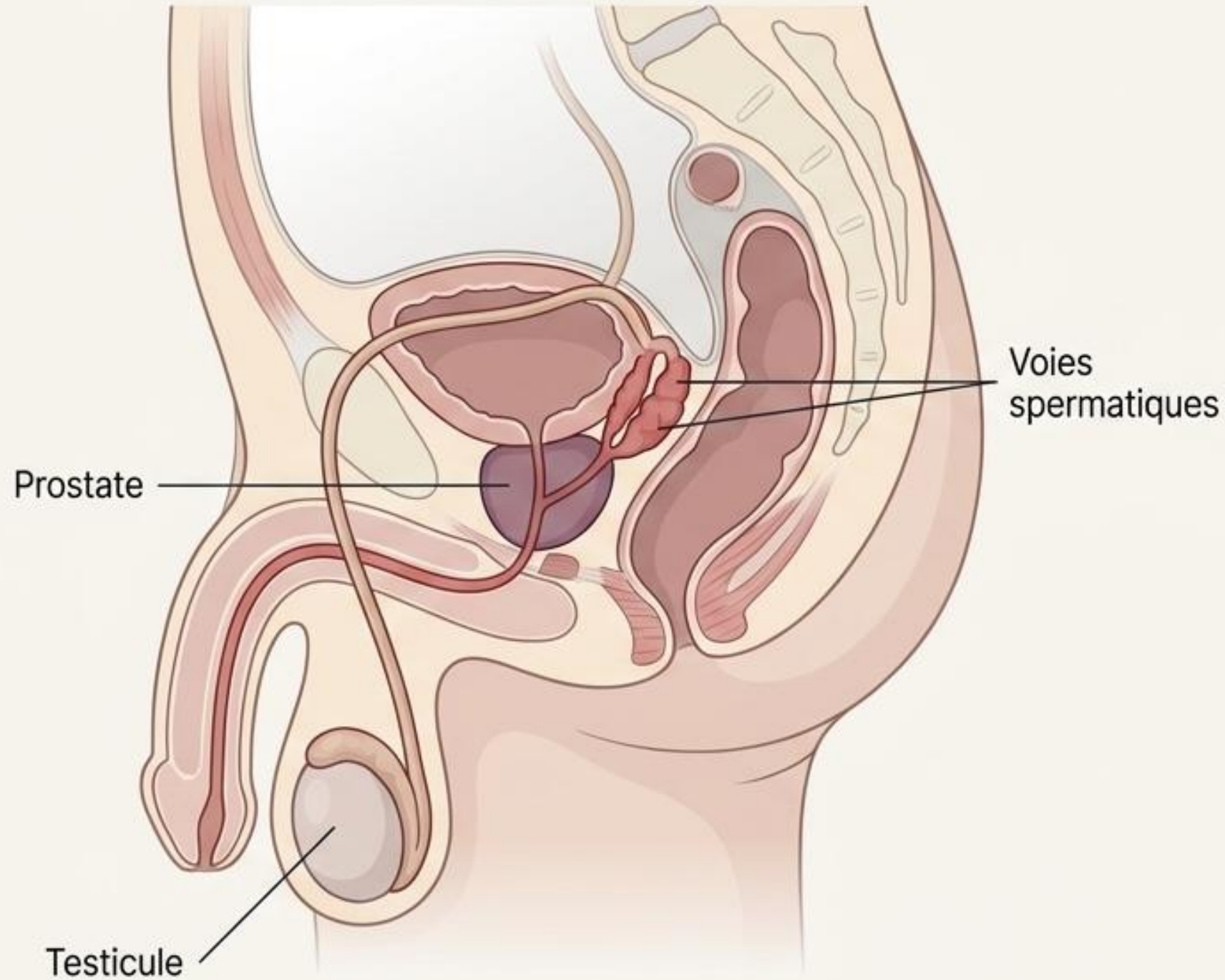


Appareil Reproducteur Masculin

Anatomie, Clinique et Approche ROP



L'architecture pelvienne et les enjeux de la soixantaine



Le défi clinique

À la soixantaine, le déséquilibre hormonal provoque l'hypertrophie prostatique. Conséquences : pression sur l'urètre/vessie, troubles de la statique pelvienne, lombo-sciatalgies, et impact psycho-émotionnel majeur (perte de confiance, troubles sexuels).

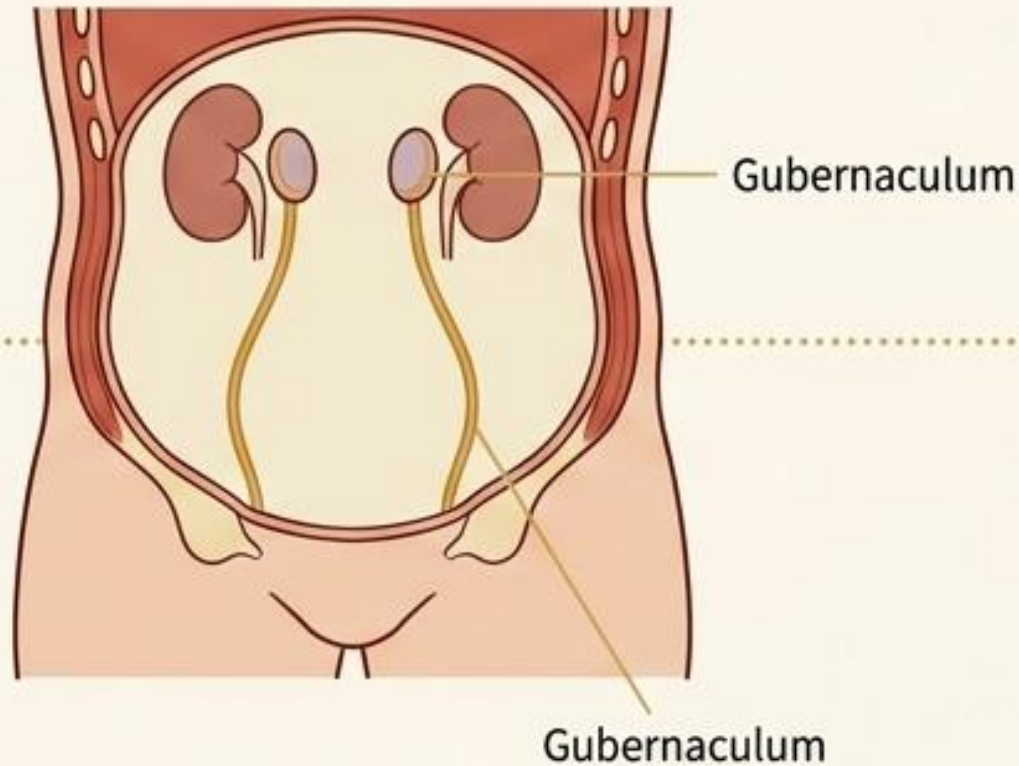
L'approche ROP

Contrairement à la chirurgie ou aux médicaments (risques d'impuissance, incontinence, éjaculation rétrograde), la ROP offre une action réflexe à distance. Elle diminue les congestions pelviennes sans effets iatrogènes tout en préservant la pudeur du patient.

La migration embryonnaire détermine les correspondances réflexes

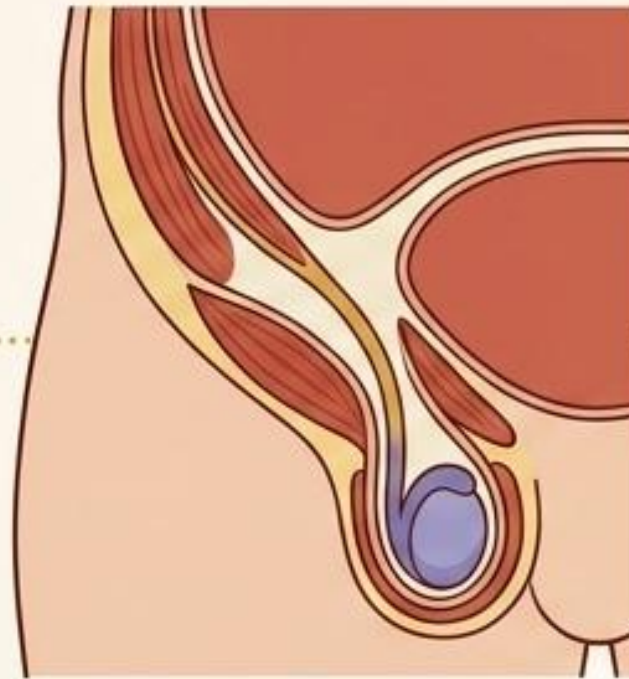
3ème mois :

Formation des gonades près des reins, guidées par le gubernaculum.



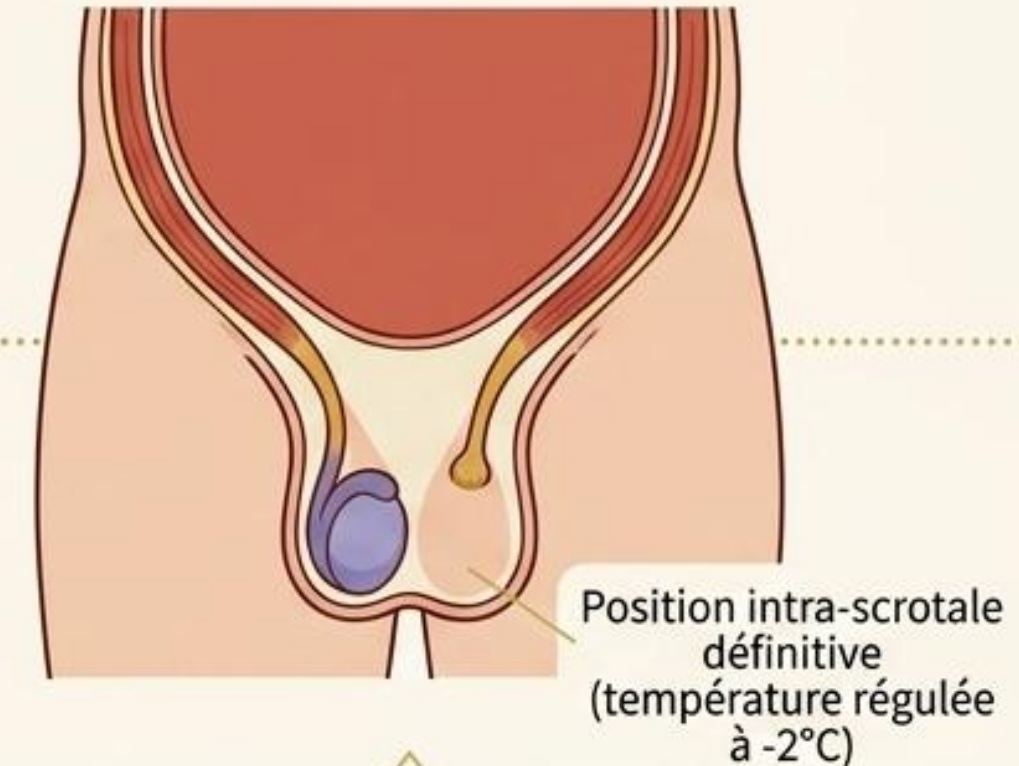
7ème mois :

Franchissement du canal inguinal.



8ème mois :

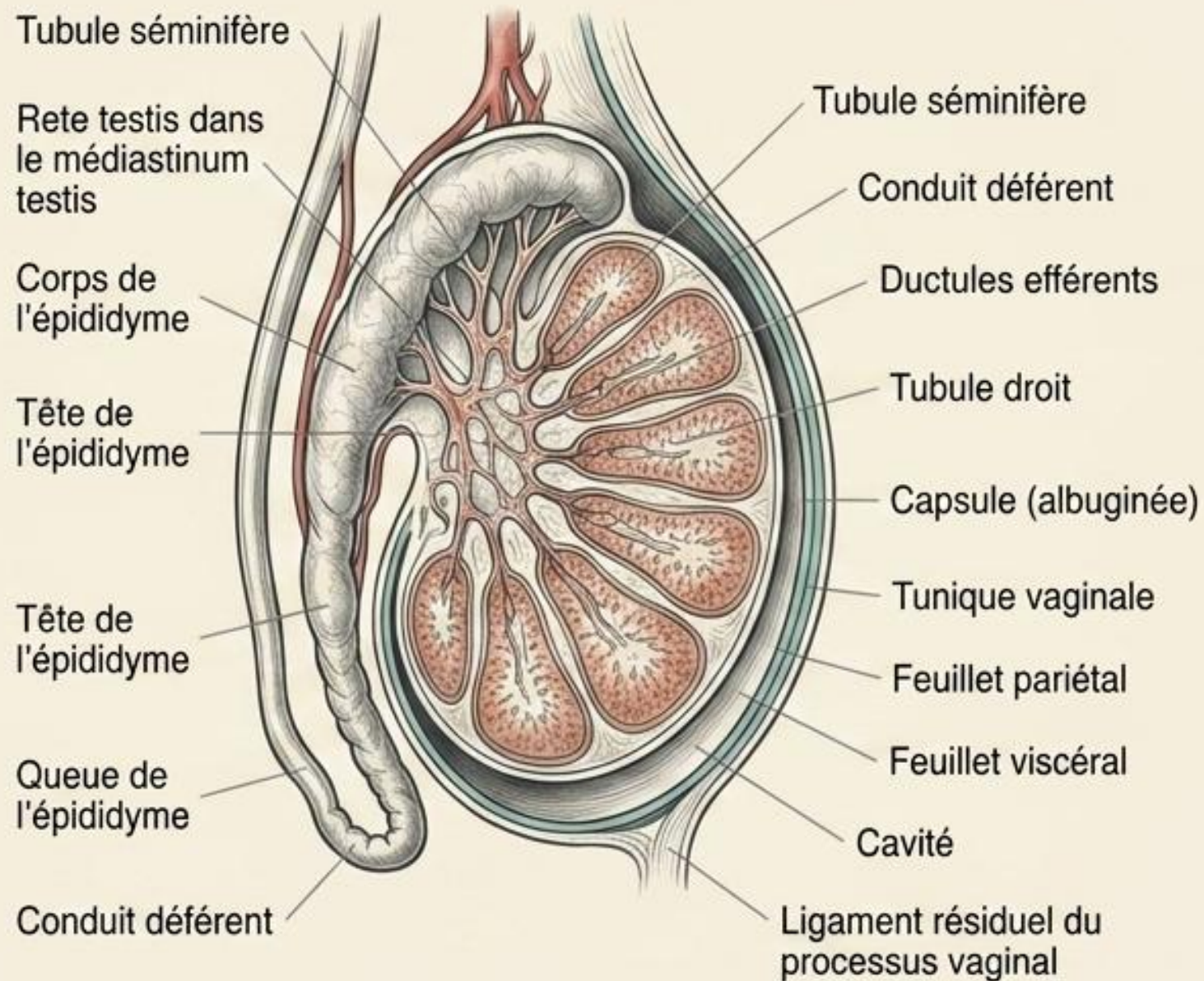
Position intra-scrotale définitive (température régulée à -2°C).



Insight ROP :

La genèse embryologique explique pourquoi les ovaires et les testicules partagent la même zone réflexe podale. Tous deux naissent dans la région rénale avant leur migration divergente.

La Double Usine Testiculaire



1. Spermatogenèse (Fonction exocrine)

Tubules séminifères



Rete testis



Épididyme (maturation et stockage)

2. Stéroïdogénèse (Fonction endocrine)

Axe hypothalamo-hypophysaire (FSH/LH)



Production de testostérone



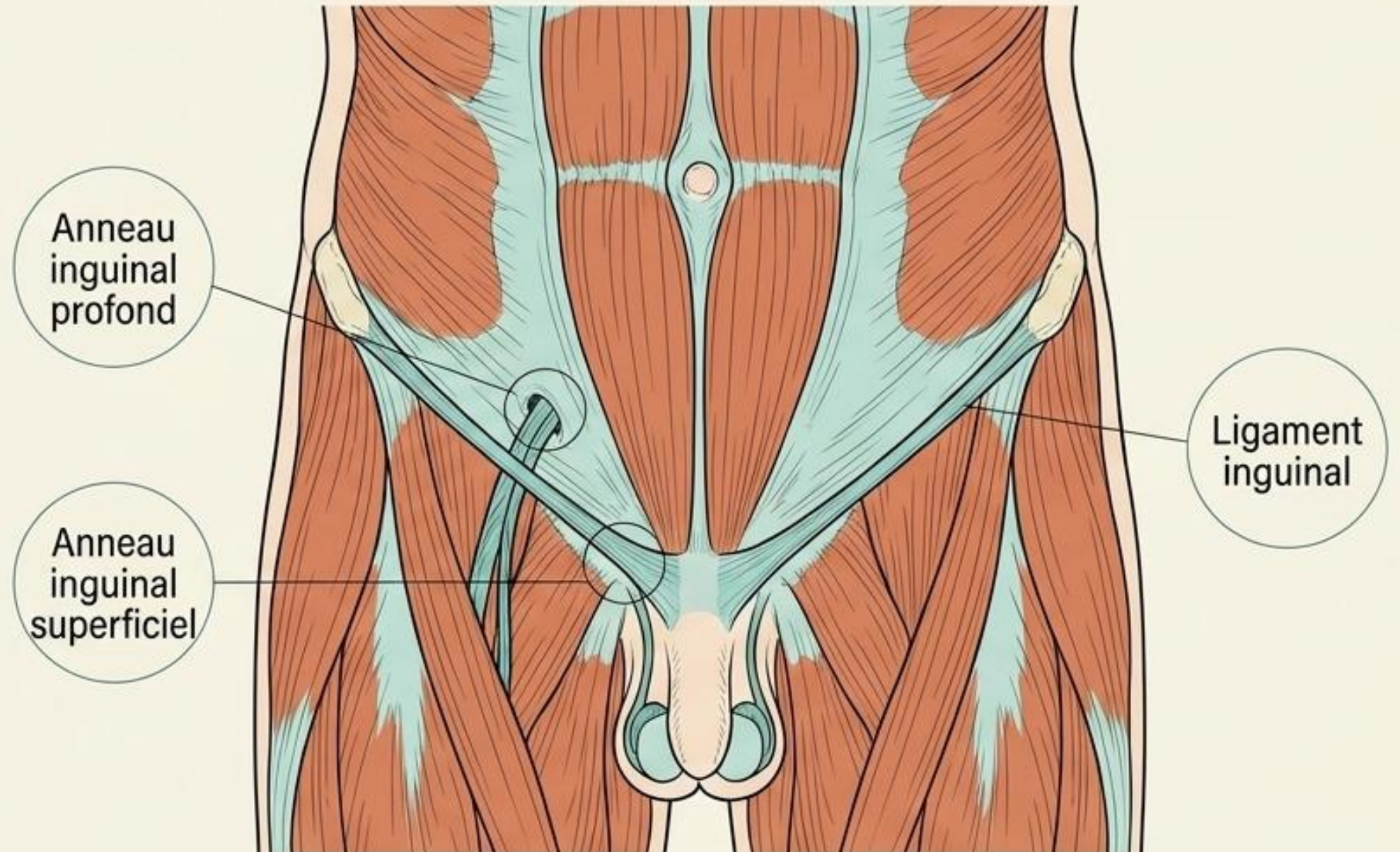
Régulation et différenciation

Le carrefour inguinal forme un tunnel de transition sous pression

Architecture du tunnel (4 cm) :

Traverse la paroi abdominale au-dessus du ligament inguinal.

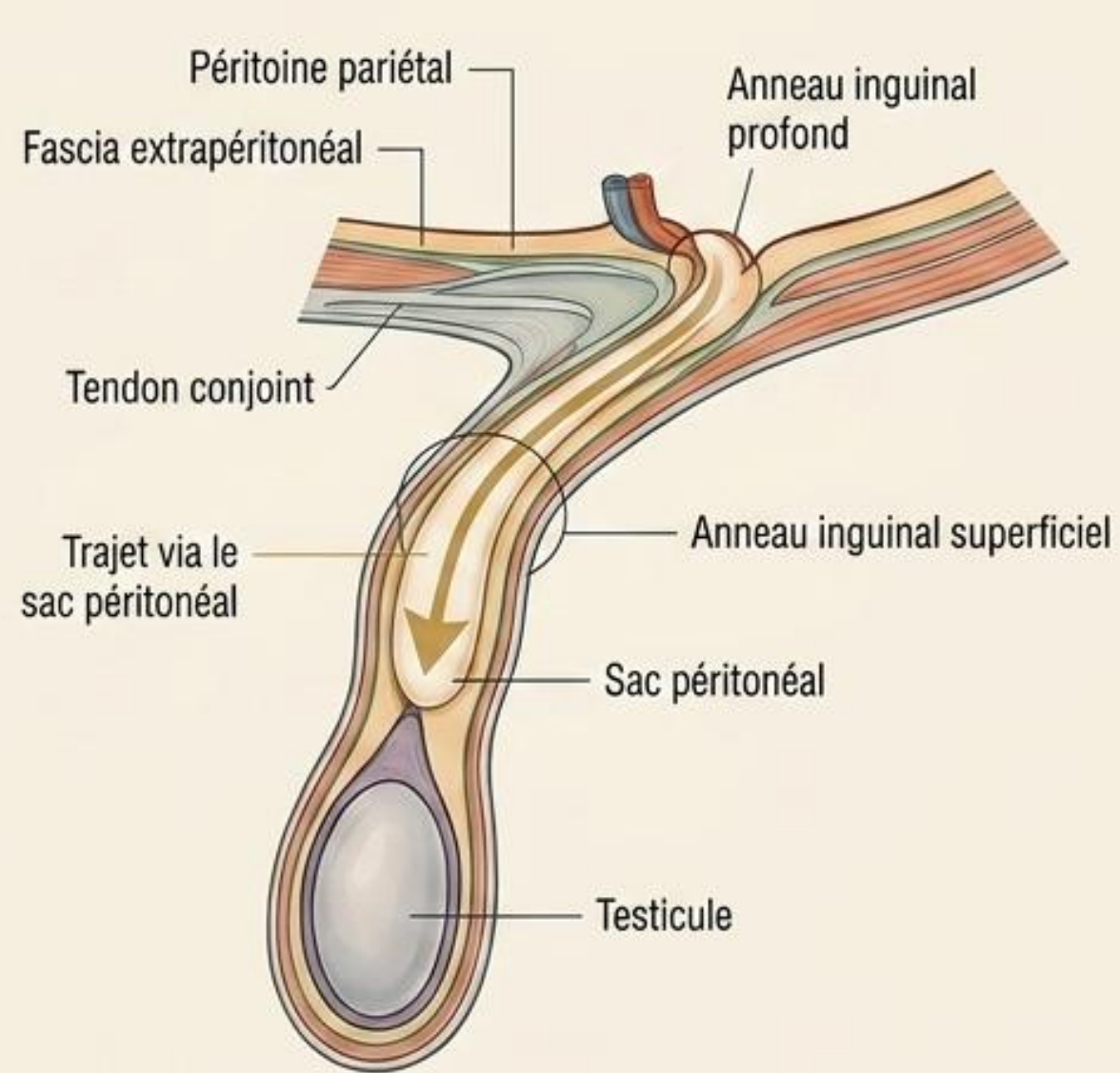
Contient le cordon spermatique : vaisseaux inguinaux, canal déférent, nerfs sensitifs (iliohypogastrique, ilioinguinal, génitofémoral - plexus L1-L4).



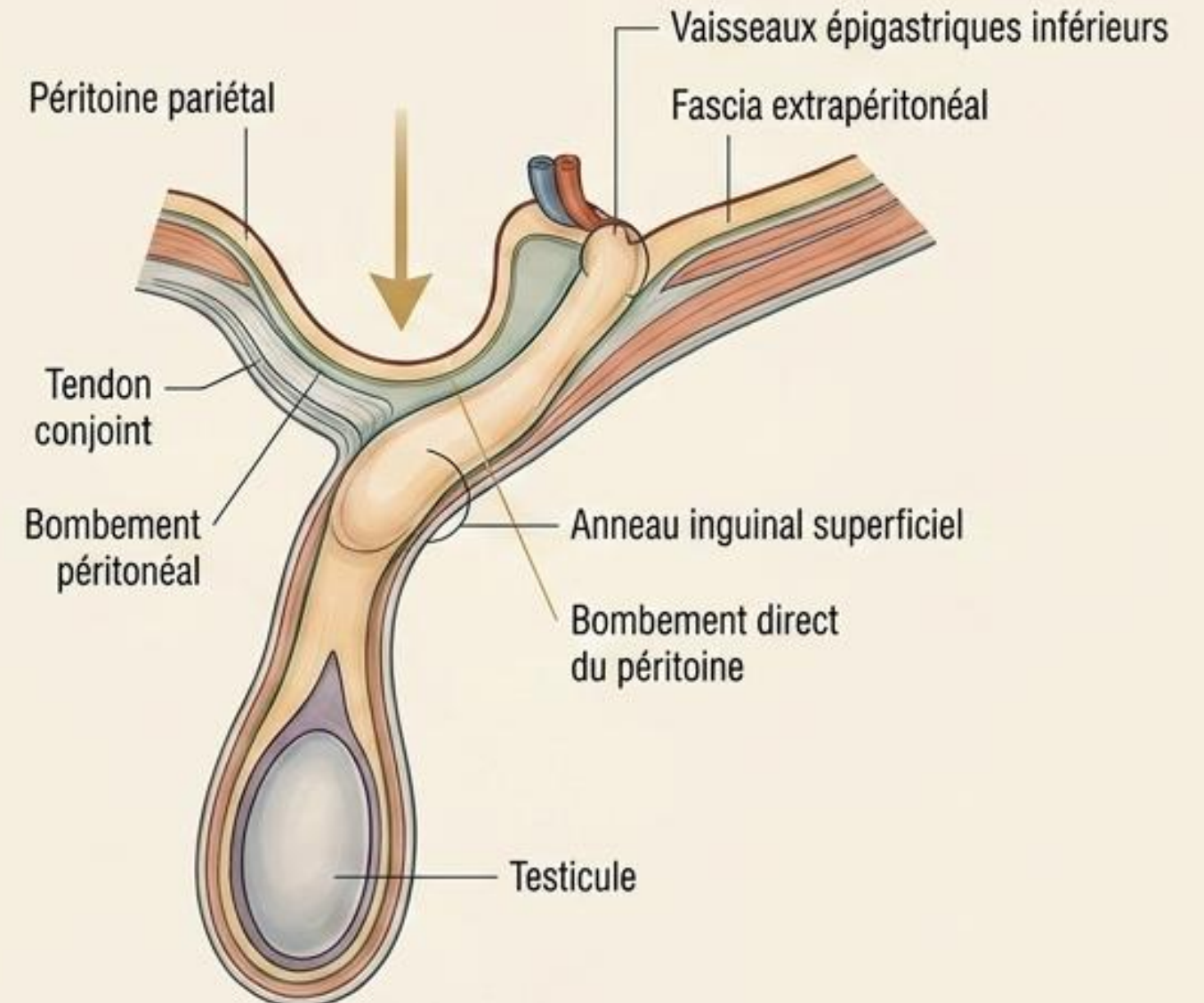
Insight ROP : Une action réflexe sur le ligament inguinal et ses orifices permet d'équilibrer les pressions intra-canales, soulageant la tension vasculaire et nerveuse du cordon spermatique.

Mécaniques herniaires

Hernie indirecte

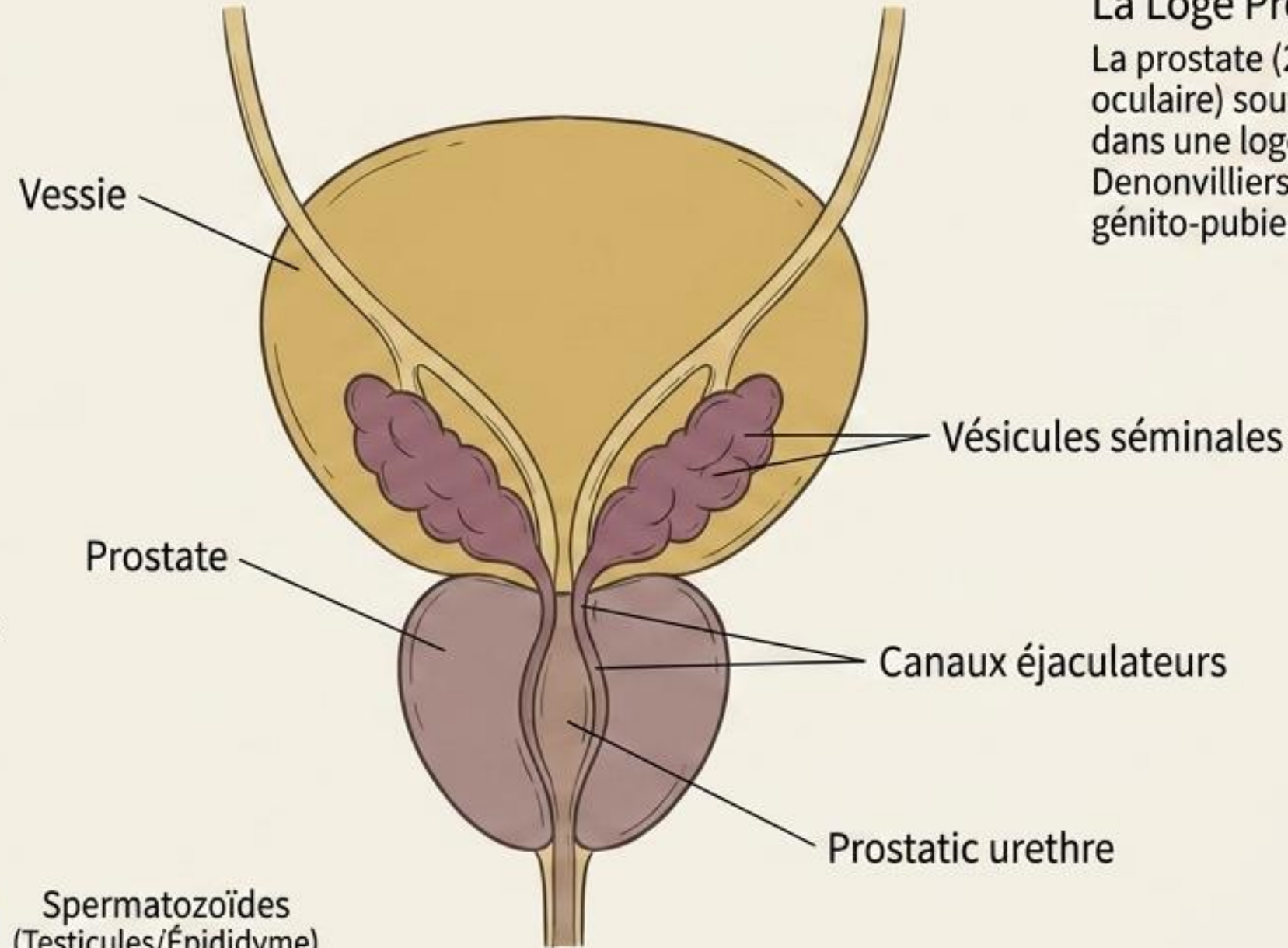


Hernie directe



Note : Le canal inguinal constitue une zone de faiblesse naturelle de la paroi abdominale, nettement plus exposée chez l'homme.

Le complexe prostatique et la constitution du fluide séminal

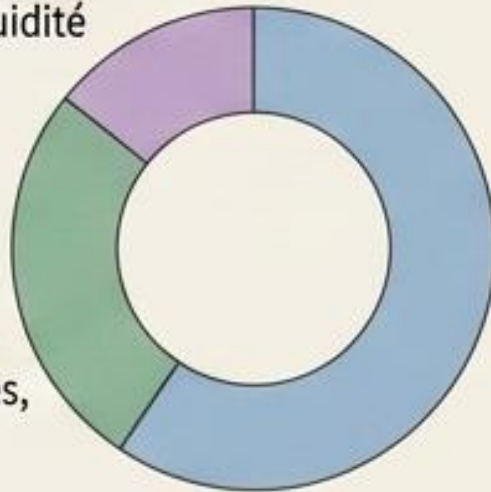


La Loge Prostatique :

La prostate (20-25g, consistance d'un globe oculaire) soutient la vessie. Elle est contenue dans une loge fermée par l'aponévrose de Denonvilliers et les lames sacro-recto-génito-pubiennes.

Composition du sperme :

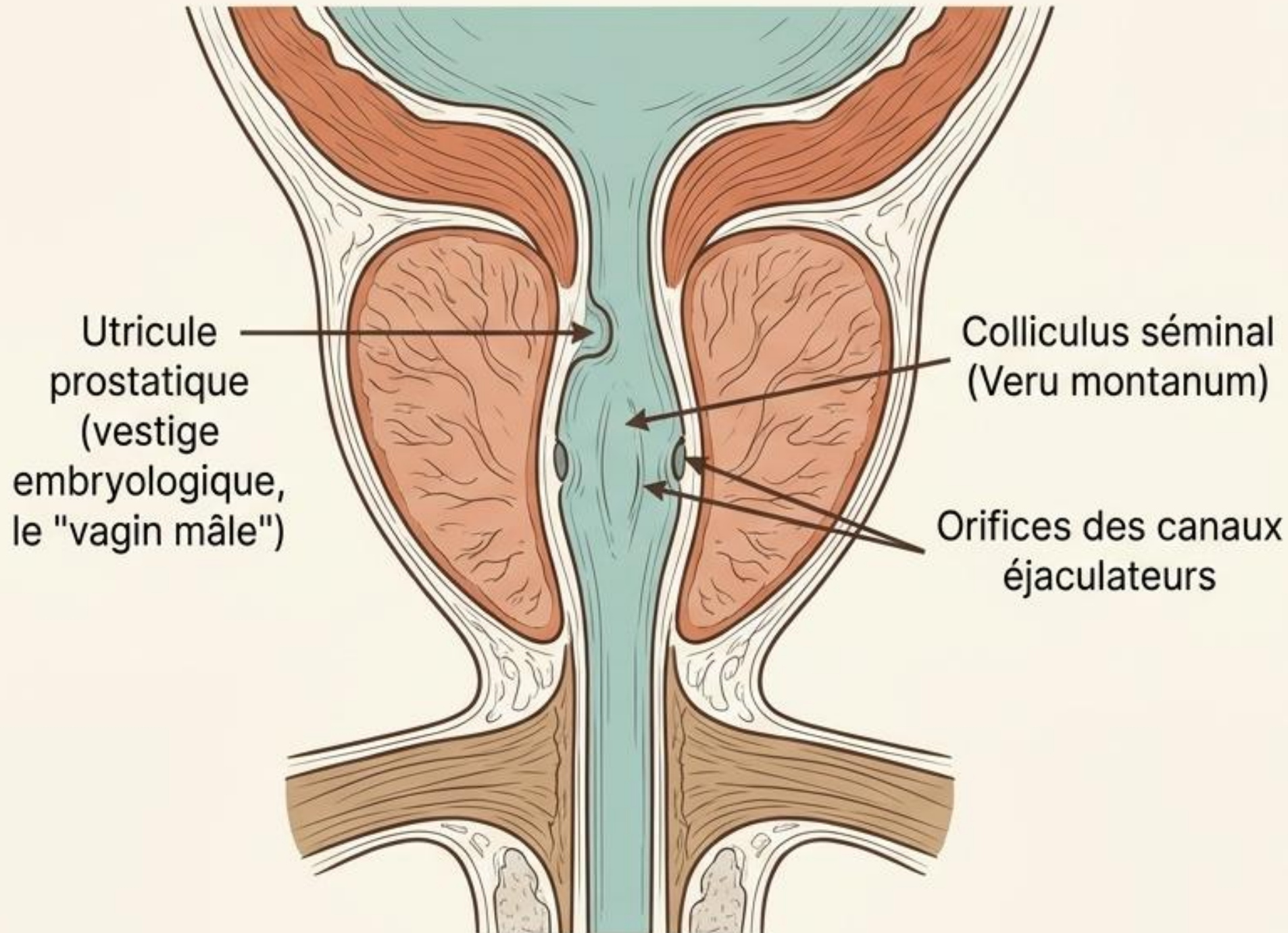
Sécrétions prostatiques :
Zinc, enzymes (PSA), fluidité



Spermatozoïdes
(Testicules/Épididyme)

Liquide séminal
(Vésicules séminales) :
Fructose, prostaglandines,
alcalin

L'urètre prostatique contrôle le carrefour uro-génital



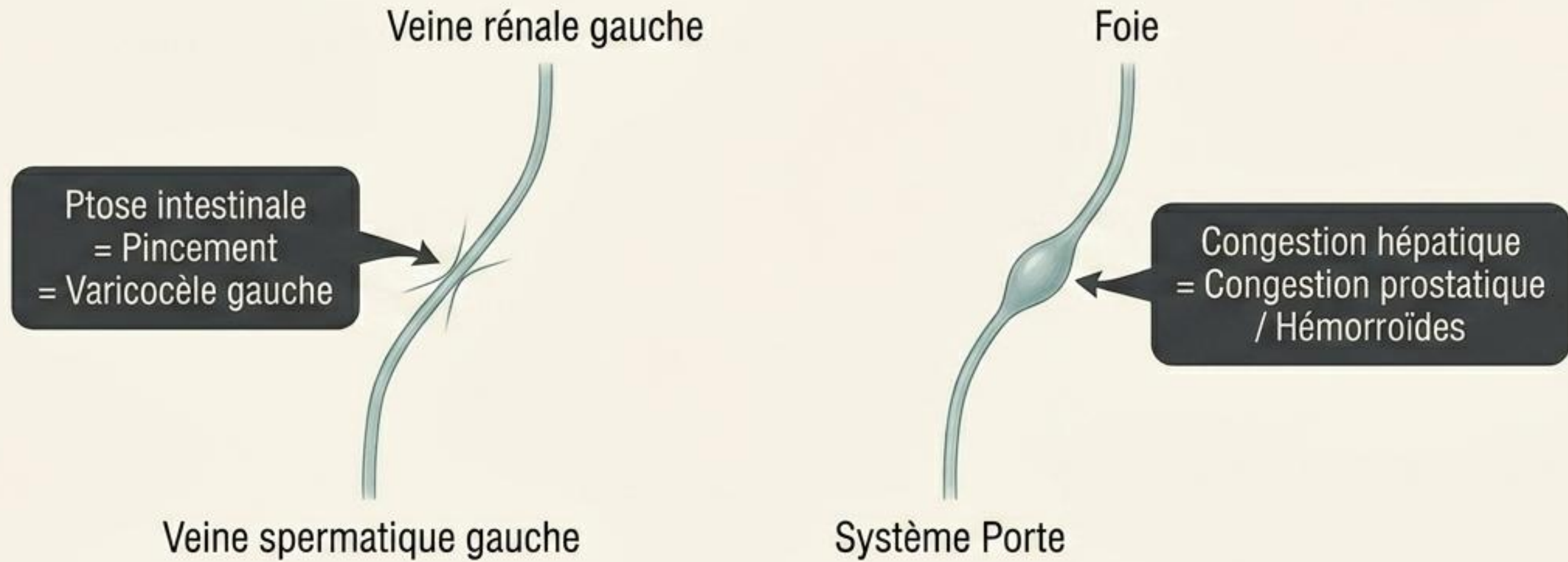
Sphincteric Control	
Sphincter Interne (Lisse)	Sphincter Externe (Strié)
Systeme Nerveux Autonome Situé au col vésical.	Volontaire (Nerf pudendal). Entoure la partie caudale.

Note Biomécanique :

Lors de l'érection, le colliculus se dilate pour empêcher la miction et l'éjaculation rétrograde.

L'hypertrophie de la prostate altère l'efficacité de ces deux sphincters.

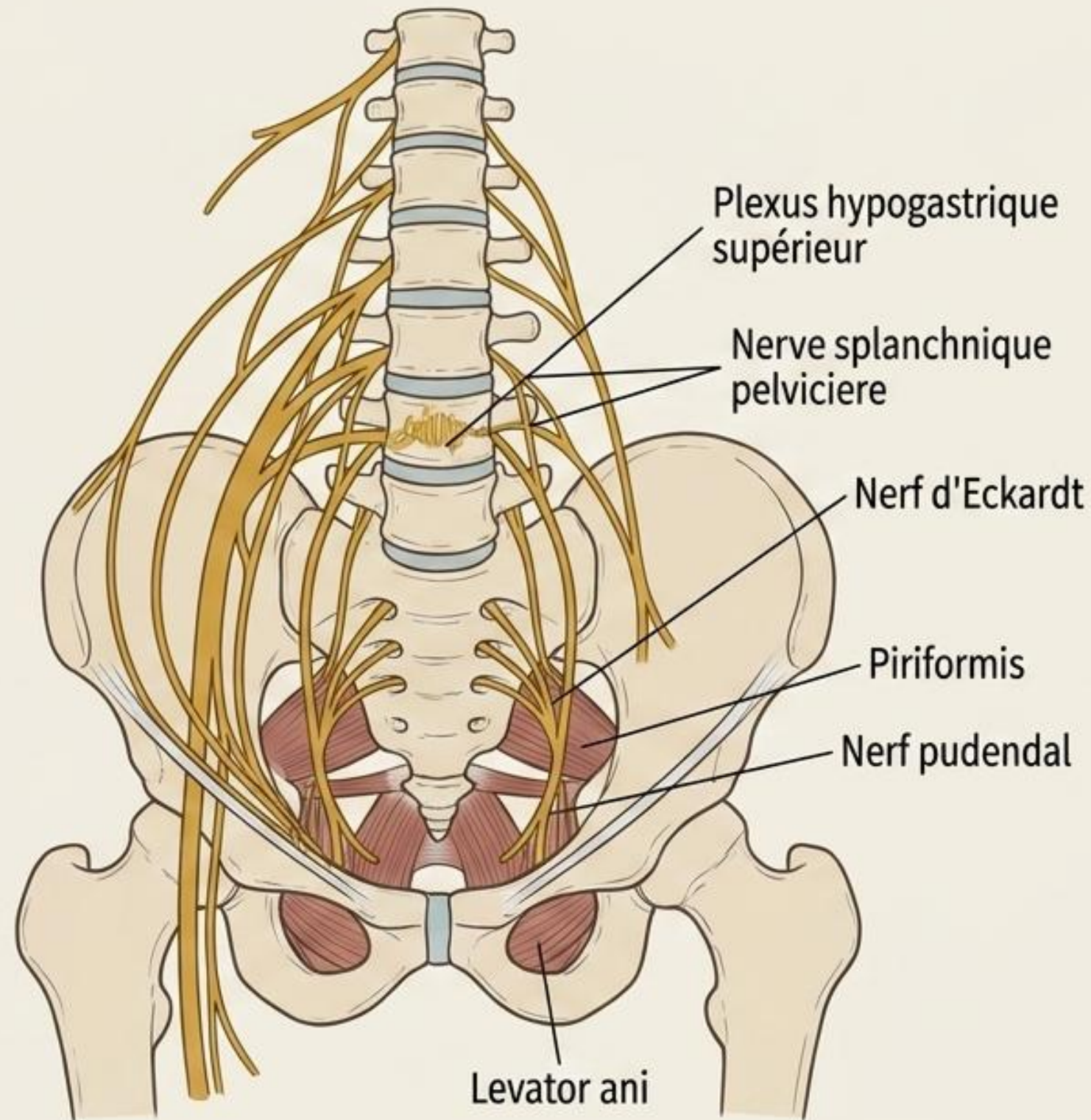
Hémodynamique et Stase Veineuse



Intérêt en ROP

Le foie, le rein gauche et l'intestin grêle sont des zones réflexes incontournables pour traiter le système uro-génital et la congestion pelvienne.

Le câblage nerveux et vasculaire dicte la mécanique pelvienne



Réseau Nerveux :

- **Sympathique** : Th10-L2 (Plexus hypogastrique supérieur).
- **Parasympathique** : S2-S4 (Nerf d'Eckardt pour les organes pelviens).

Le Piège Veineux :

Veine spermatique droite → Veine cave

Veine spermatique gauche → Veine rénale gauche

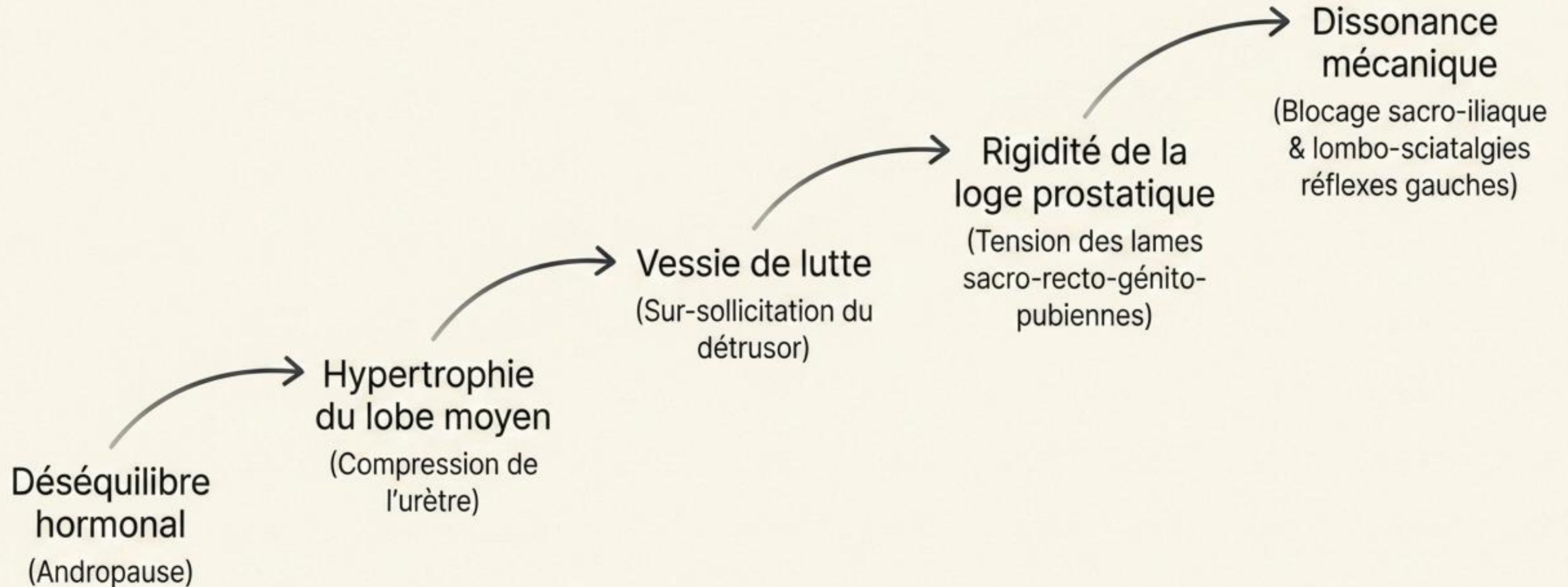
Insight Pratique ROP :

Le clampage de la veine rénale gauche par ptose de l'intestin grêle (pince aorto-mésentérique) ou une stase hépatique crée un barrage veineux. Résultat : varicocèle gauche et varices du membre inférieur. Il faut traiter le foie et le rein gauche.

Matrice diagnostique des pathologies

PATHOLOGIE	ÂGE TYPIQUE	SYMPTÔMES CLÉS	NOTES CLINIQUES
Hypertrophie Bénigne (HBP)	> 60 ans (50%)	Dysurie, jet faible, sciatalgie	Tumeur bénigne du lobe moyen (hormonale).
Cancer de la Prostate	> 50 ans	Souvent asymptomatique au début	Adénocarcinome (zone périphérique), hausse du PSA libre.
Cancer du Testicule	15-35 ans	Grosueur, lourdeur	Urgence, risque de métastases.
Torsion Testiculaire	Puberté / Périnatale	Douleur soudaine intense	Urgence chirurgicale (nécrose en 6h).

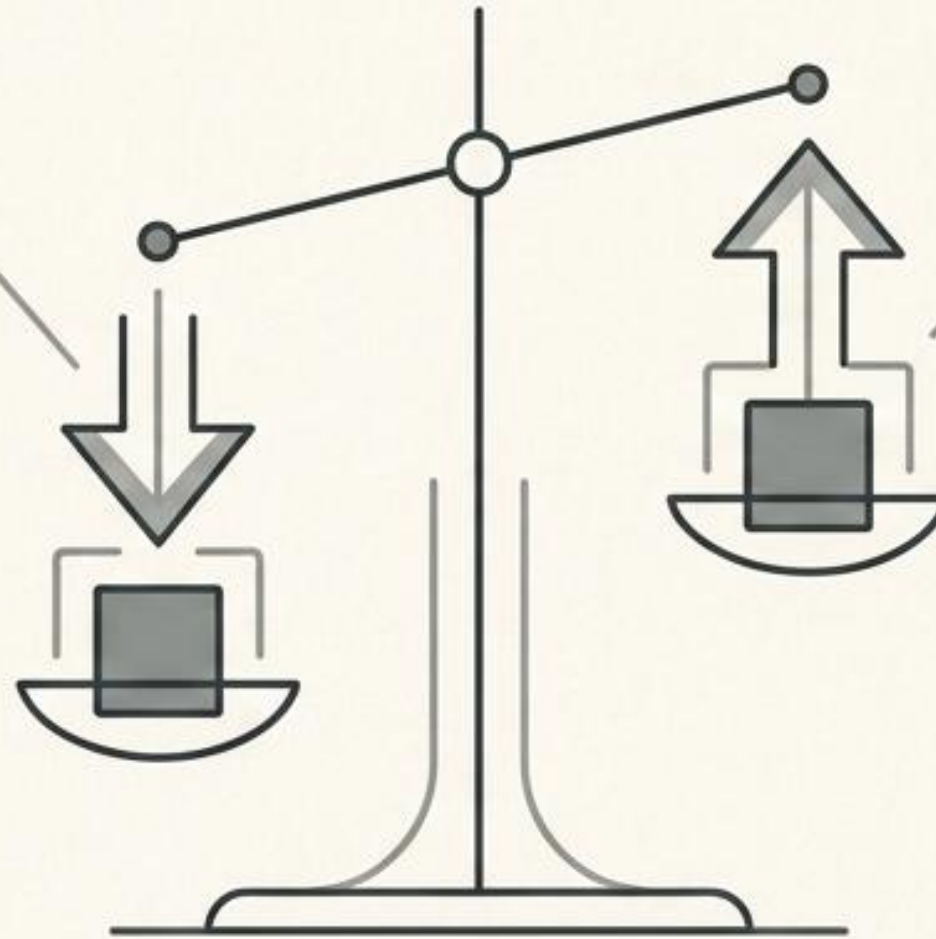
La Dissonance Mécanique : L'Effet Cascade de l'HBP



La Dimension Psycho-Émotionnelle

Le Fardeau Social & Émotionnel

- Perte de statut social (Retraite)
- Peur de la panne sexuelle / Perte d'identité
- Pression sociétale et relationnelle



La Réponse Physiologique

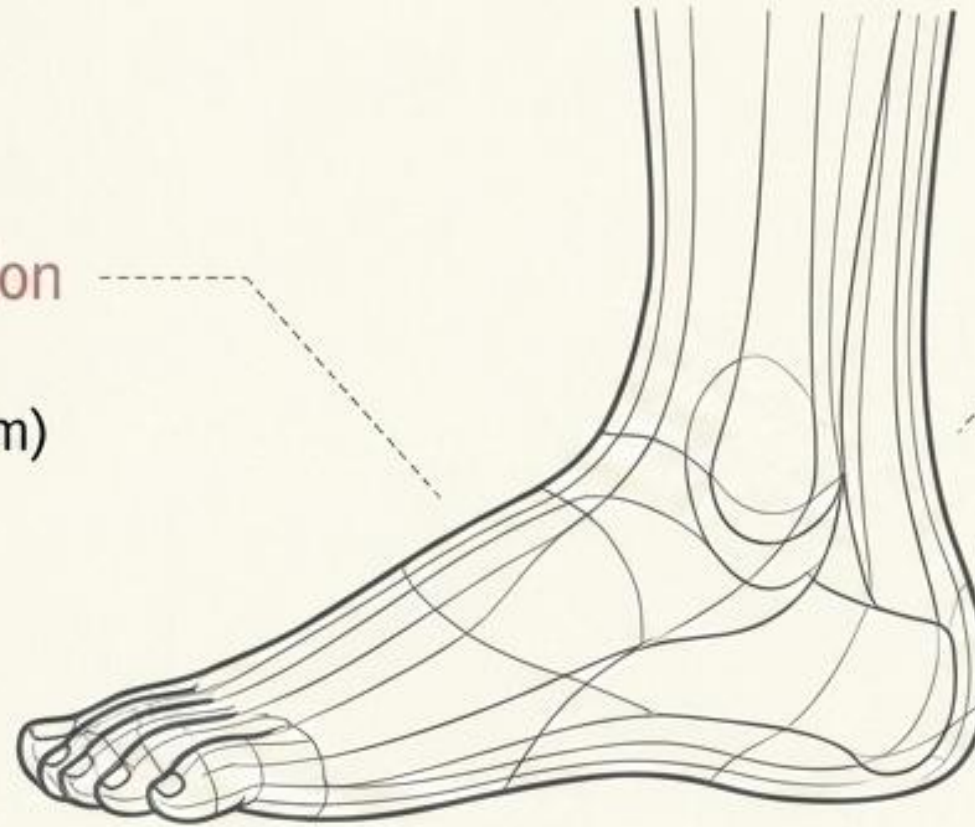
- Perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire
- Stress chronique affectant le système limbique
- Augmentation massive de la tension tissulaire prostatique

La prostate réagit fortement aux états de stress. L'accompagnement ROP doit systématiquement intégrer l'écoute du cerveau limbique pour désamorcer la tension tissulaire.

Synthèse Thérapeutique ROP

1. Syndrome Général d'Adaptation

- Axe limbique (cerveau/prostate)
- Sympathique (Th10-Th12, L5, Sacrum)
- Parasympathique (S2-S4)
- Foie, Rein gauche

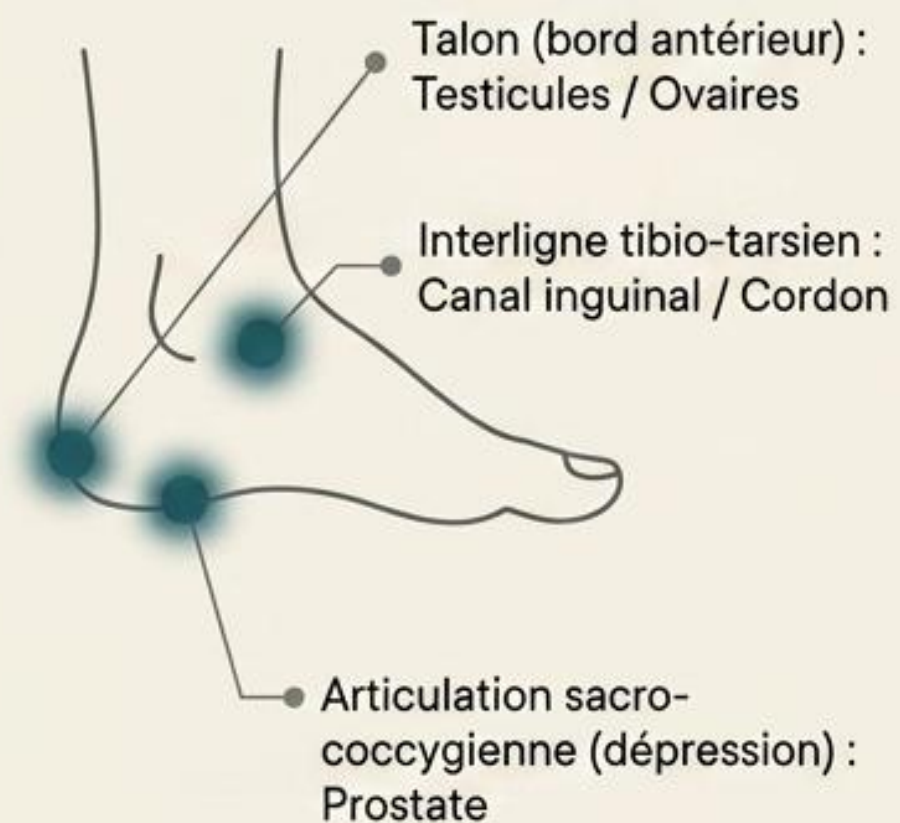


2. Syndrome Loco-Régional

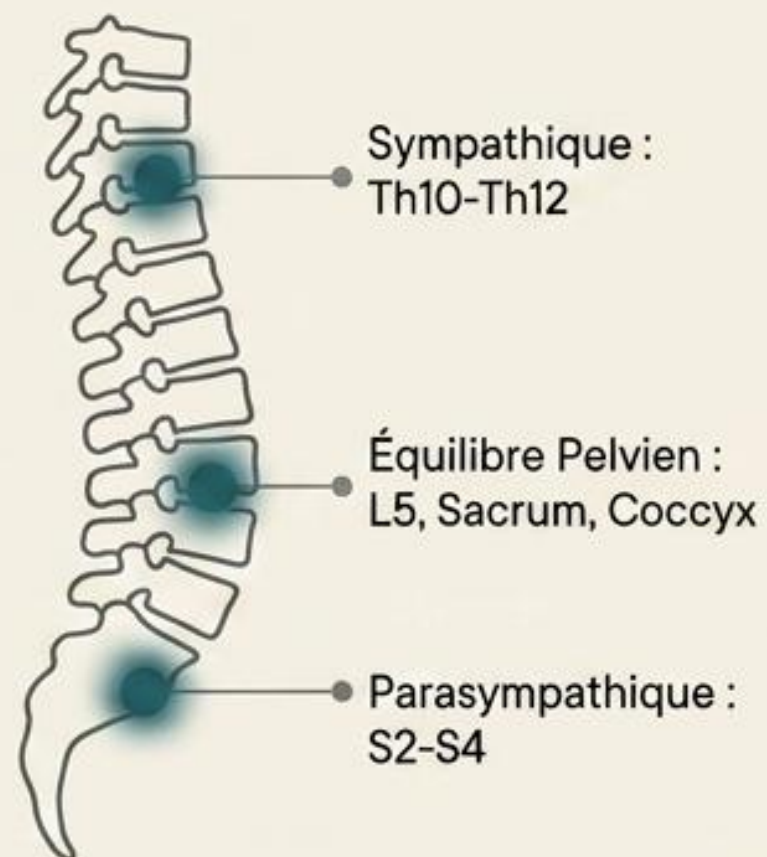
- Testicules (bord antérieur du talon)
- Canal inguinal (interligne tibio-tarsien antérieur)
- Prostate (dépression en avant de la sacro-coccygienne)

Synthèse Pratique ROP : Cartographie du Protocole

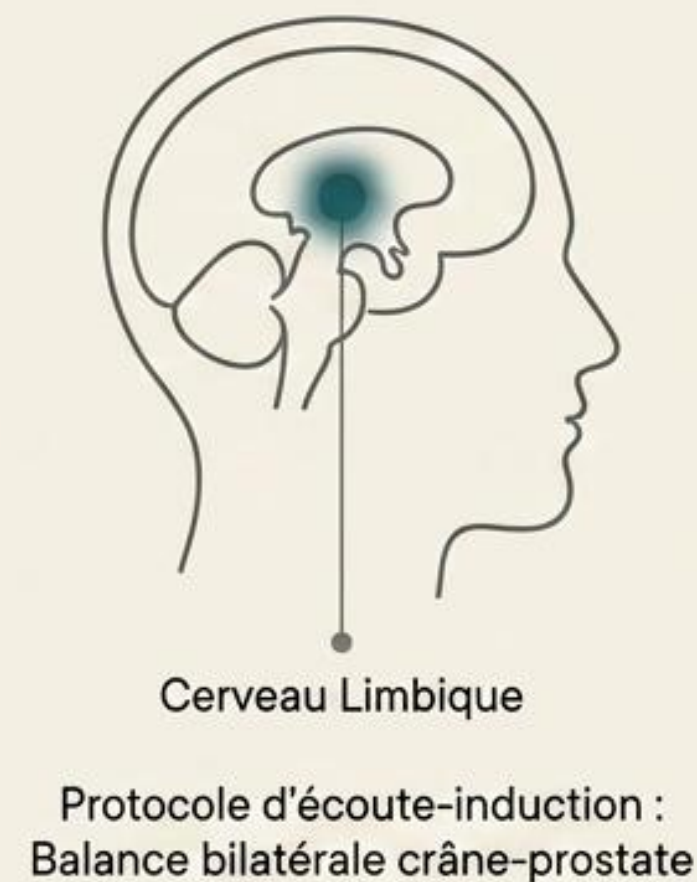
Zones Podales



Zones Médullaires



Axe Crânien



**La Réflexologie Occipito-Podale contribue
à diminuer les conséquences des troubles prostatiques
sans effets iatrogènes, dans le respect de la pudeur.**

L'alliance d'une action neuro-vasculaire précise et d'une prise en charge globale.